

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Erreur médicamenteuse

Conduite à tenir devant erreur de patient, dose, médicament, voie, horaire ou administration connue ou suspectée.

Indications

- Erreur constatée avant ou après administration.
- Risque médicamenteux potentiel pour le résident.
- Besoin de sécurisation immédiate et d'évaluation clinique.

Vérifications préalables

- Identifier médicament, dose, voie, heure et résident concerné.
- Évaluer si le produit a été administré ou seulement préparé.
- Prendre paramètres et rechercher symptômes immédiats.
- Conserver emballage, ordonnance et pilulier utiles à l'analyse.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas masquer l'événement.
- Ne pas corriger par seconde administration sans avis.
- Ne pas retarder l'appel médical si médicament à risque.
- Ne pas oublier déclaration interne / EI.
- Règle des 5B : Bon résident/patient, Bon médicament, Bonne dose, Bonne voie, Bon moment.

Conduite à tenir

- Sécuriser le résident et interrompre toute administration complémentaire.
- Informer immédiatement IDE/médecin et si nécessaire pharmacien.
- Appliquer consignes médicales de surveillance ou correction.
- Déclarer selon procédure qualité de l'établissement.

Surveillance et traçabilité

- Tracer erreur, heure, contexte, évaluation clinique et consignes reçues.
- Surveiller effets attendus ou indésirables selon médicament.
- Documenter information donnée à l'équipe et au résident si pertinent.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide pour toute erreur administrée ou médicament à risque.
- Appel 15 / centre antipoison si tableau toxique, erreur massive ou produit dangereux.

Mention de sécurité

Une erreur médicamenteuse est d'abord une urgence clinique potentielle, puis un événement qualité à analyser. Rappel : règle des 5B.

Fait à :

Le : / /

Signature :